



DOUTOR - AI · KICKOFF GETCONNECT

Dossiê do *Cliente*

GetConnect Gestão em Saúde

PS Digital Inteligente

▸ NESTE DOSSIÊ

O currículo da *conta*

Documento-chave que reúne tudo da GetConnect: contexto, dores, contrato, escopo, fluxos, integrações, preços e receita. Vivo durante todo o relacionamento.

01 Snapshot da conta

Números-chave, contrato e status

02 Contatos & Círculo de Ouro

Quem é quem + a tese da solução

03 Timeline & contexto

Reuniões, participantes e decisões

04 Dores & sucesso do projeto

Por que buscam IA e como medir valor

05 O que foi contratado

Fluxo + escopo, frentes e protocolo

06 Fluxo detalhado do escopo

A jornada passo a passo (proposta)

07 Integrações, dados & LGPD

App, web, Twilio, prontuário, protocolo

08 Contrato & precificação

Etapas, custos e janela de volume

10 Tamanho do PS Digital & MRR

Volumetria e receita por fase

11 Riscos, exclusões & limitações

O que vigiar e o que está fora

12 Cronograma (macro)

Discovery → plano → implantação → go-live

▸ SEÇÃO 01 • SNAPSHOT

Visão geral da *conta*

19/jun

CONTRATO ASSINADO
via ClickSign

—

DISCOVERY
gatilho da implantação

3

DOMÍNIOS ATIVOS
Triagem • Teleconsulta • Auditoria

60→100K

ATEND./MÊS
atual → projetado

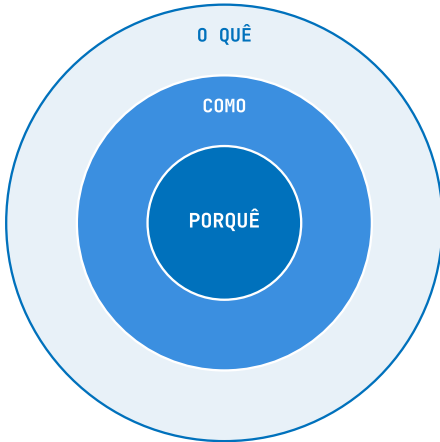
Campo	Valor
Cliente	GetConnect Gestão em Saúde LTDA • CNPJ 41.041.910/0001-08
Cliente final	Prefeitura de São Paulo – Pronto-Socorro Digital (ecossistema e-Saúde SP)
O que foi vendido	Camada de IA clínica embarcada no ecossistema GetConnect (app do paciente + plataforma web de telemedicina)
Contrato	Contrato-Quadro SaaS • assinado via ClickSign em 19/06/2026 • base 27/05/2026
Modelo	SaaS modular • cobrança variável por atendimento
Canal oficial	suporte@doutor-ai.com (ativação, expansão, aprovação de horas)
Status	Contrato ativo • aguardando e-mail de ativação dos domínios + pagamento do Discovery

SEÇÃO 02 • CONTATOS & CÍRCULO DE OURO

Quem é quem & a tese

Nome	Papel	Vínculo	E-mail
Marcelo Fanganiello	Proprietário · decisor	ASSINANTE	marcelo@getconnect.com.br
Luiz Claudio Camargo	CEO	SPONSOR	luiz@getconnect.com.br
Matheus Oliveira	Produto / técnico	CHAMPION TÉC.	matheusgoncalves@getconnect.com.br
Luís	Time técnico	TÉCNICO	—
Lidya	Produto / técnico	PRODUTO	—

Confirmar e-mail oficial de notificações da GetConnect (campo em branco no contrato).



PORQUÊ • Marcelo • Luiz
Ganhar escala no PS Digital público sem trocar de sistema — IA como apoio, validação humana sempre.

COMO • Matheus • Luís • Lidya
Camada de IA embarcada no app + plataforma web + Twilio; jornada em 4 etapas, 100% validada pela enfermagem.

O QUE • Enfermagem • Médicos • Auditoria
Triagem inteligente, copiloto de teleconsulta, transcrição e auditoria de assertividade.

▸ SEÇÃO 03 · TIMELINE & CONTEXTO

A história em *contexto*

Histórico e conversas consolidados — cruzando atas do Gemini, o grupo de WhatsApp, Read.ai e a proposta. Cerca de 7 reuniões entre o evento HMS e a assinatura.

Q1 2026

Primeiro contato — evento HMS[Maurício](#) · [GetConnect](#)

Maurício aborda a GetConnect numa demonstração de IA (Gemini), em torno de leitura de laudos de imagem (mamografia/BIRADS). Origem da relação.

01/04/2026

Reunião inicial (online · Meet / ata Gemini)[Convite: Luiz Camargo, Marcelo, Matheus, Lídia](#) · [André Chade, André Ferreira, Mauricio](#)

Luiz apresenta o e-Saúde SP (6,5M downloads, 1,6M ativos/mês, 80+ sistemas integrados; telemedicina obrigatória por lei no município). André Chade demonstra o copiloto clínico (atendimento em 6 cliques). Modelo de cobrança por atendimento via API. Grupo de WhatsApp criado no mesmo dia.

≈28-29/04/2026

Reunião presencial em São Paulo (semana de 27/04)[Doutor-AI \(presencial\)](#) · [Matheus, time GetConnect](#)

Gustavo Barcelos resume: forte sinergia, foco no projeto com a Prefeitura de SP. Próximos passos: fluxo de triagem híbrida (áudio+texto via chat), telefone como canal complementar, módulo de transcrição/registro estruturado no super app GetConnect e camada de auditoria clínica.

08/05/2026

Workshop do fluxo de triagem (online · Meet / ata Gemini)[Convite: Mauricio, André Chade, Gustavo Barcelos](#) · [Matheus, Lídia](#)

Desenho do fluxo: triagem → enfermagem → médico → auditoria N1/N2/N3. Twilio grava e transcreve em <30s; IA pré-preenche 80-90% do formulário. Volume 60K→90-100K (MVP), consórcio 250K. Decidido fazer POC de implantação — variáveis por etapa.

≈21/05/2026

Apresentação da proposta (presencial · semana da Hospitalar)[Marcelo, Matheus, time GetConnect](#) · [Doutor-AI](#)

Proposta com preço por atendimento e horas técnicas, apresentada ao vivo para resolver dúvidas — base do contrato.

27/05 → 16-19/06/2026

Minuta e assinatura (ClickSign)[Maurício, Thiago](#) · [Marcelo, Luiz](#)

Minuta do Contrato-Quadro em 27/05. Assinaturas: Maurício (16/06), Marcelo e Luiz (17/06); documento finalizado em 19/06/2026.

15/06/2026 **Discovery presencial** · [Maurício e Thiago](#)

▸ SEÇÃO 04 • DORES & SUCESSO DO PROJETO

Por que buscam IA

As dores que motivam o projeto, o que a GetConnect espera da IA e como o sucesso (entrega de valor) será medido — base do alinhamento com o cliente.

▸ DORES • POR QUE BUSCAM IA

- Triagem atual "clificada" e protocolo internacional (Medkitor) limitam a evolução.
- Documentação manual lenta — preencher o prontuário consome tempo do profissional.
- Precisam escalar de 60K para 90–100K (consórcio 250K) sem trocar de sistema.
- Alta demanda espontânea no PS Digital exige pré-filtro e pré-classificação de risco.
- Setor público conservador — a validação humana precisa ser preservada.

▸ O QUE ESPERAM DA IA

- Triagem inteligente com pré-classificação de risco e relatório.
- Pré-preenchimento de 80–90% do formulário; transcrição em <30s.
- Copiloto que sugere perguntas e estrutura anamnese/evolução/condução.
- Relatório de assertividade da IA × decisão humana, com melhoria contínua.

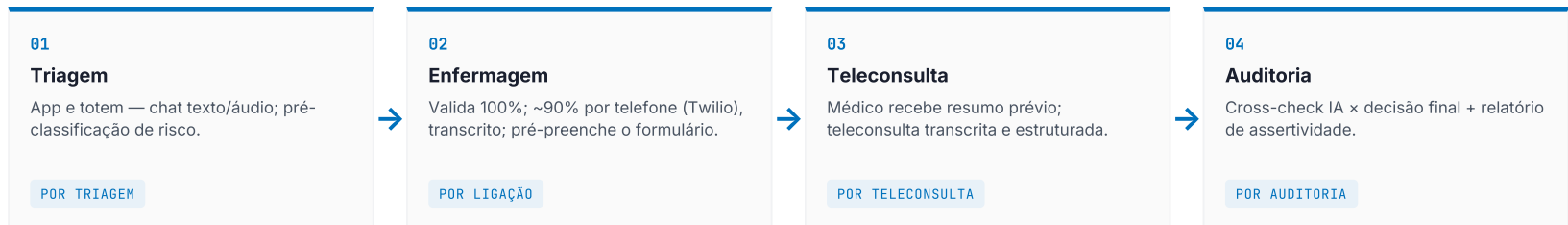
▸ COMO MEDIMOS O SUCESSO

- Redução do tempo de atendimento e de documentação (case: -50% no tempo de consulta).
- Produtividade da enfermagem e da medicina (mais atendimentos por profissional).
- 80–90% do formulário pré-preenchido pela IA.
- Assertividade da IA crescente ao longo do tempo.
- Disponibilidade 99,5% e validação humana mantida em 100%.

▸ SEÇÃO 05 • O QUE FOI CONTRATADO

O que foi *contratado*

Contrato-Quadro guarda-chuva: a recorrência incide só sobre os domínios ativados. A jornada da IA em 4 etapas, com validação humana 100%.



▸ DOMÍNIOS ATIVOS

- **Triagem** — chat (texto + áudio), no app e no totem.
- **Teleconsulta** — apoio à enfermagem e ao médico (web).
- **Auditoria dos Atendimentos** — cross-check + assertividade.

▸ ESCOPO & DEPENDÊNCIAS

- Triagem roda em **2 frentes**: totem (Frente 1) e app (Frente 2) — detalhe na seção de tamanho.
- **Substitui o protocolo internacional usado hoje (Medkitor)** pela triagem inteligente Doutor-AI.
- Integração via API/SSO ao ecossistema — sem troca de sistema assistencial.
- Expansões (PS físico, internação, crônicos, faturamento) ativáveis por e-mail.

▸ SEÇÃO 06 • FLUXO DETALHADO DO ESCOPO

O fluxo em *detalhe*

Detalhamento da jornada conforme a proposta — o passo a passo de cada etapa, validado no workshop de 08/05.

01 • TRIAGEM (APP / TOTEM)**Coleta inteligente**

- Paciente abre atendimento no app e-Saúde ou no totem (demanda espontânea, sem agendamento).
- Chat por texto e áudio (tipo WhatsApp) — sem ligação na triagem, para otimizar custo.
- Substitui a triagem 'clícada' atual e o protocolo internacional (Medkitor).
- IA direciona as perguntas, capta sintomas e sinais de alerta.
- Saída: pré-classificação de risco + relatório de risco para a enfermagem.

02 • ENFERMAGEM + TWILIO**Validação humana**

- 100% dos casos passam pela enfermeira (setor dedicado decide o encaminhamento ao médico).
- Contato com o paciente ~90% por telefone (Twilio); áudio gravado e transcrito após o término (<30s).
- IA pré-preenche 80–90% do formulário padrão do PS Digital; a enfermeira confirma e completa.
- IA fornece script personalizado (perguntas adicionais que a triagem não fez).
- Saída: relatório estruturado para o médico + auditoria do trabalho da enfermeira.

03 • TELECONSULTA MÉDICA**Copiloto do médico**

- Teleconsulta na plataforma web GetConnect (voltada ao profissional).
- Médico recebe resumo prévio: triagem + validação da enfermeira + divergências + score recalculado.
- IA sugere perguntas relevantes ao médico.
- Consulta gravada, transcrita e estruturada em anamnese/evolução/conducta — médico quase não digita.

04 • AUDITORIA**Assertividade**

- Cross-check entre a recomendação da IA e a decisão final da enfermeira/médico.
- Auditoria em níveis N1, N2 e N3.
- Relatório de assertividade da IA ao longo do tempo, com melhoria contínua do modelo.
- Base para o KPI de produtividade da enfermagem e da medicina.

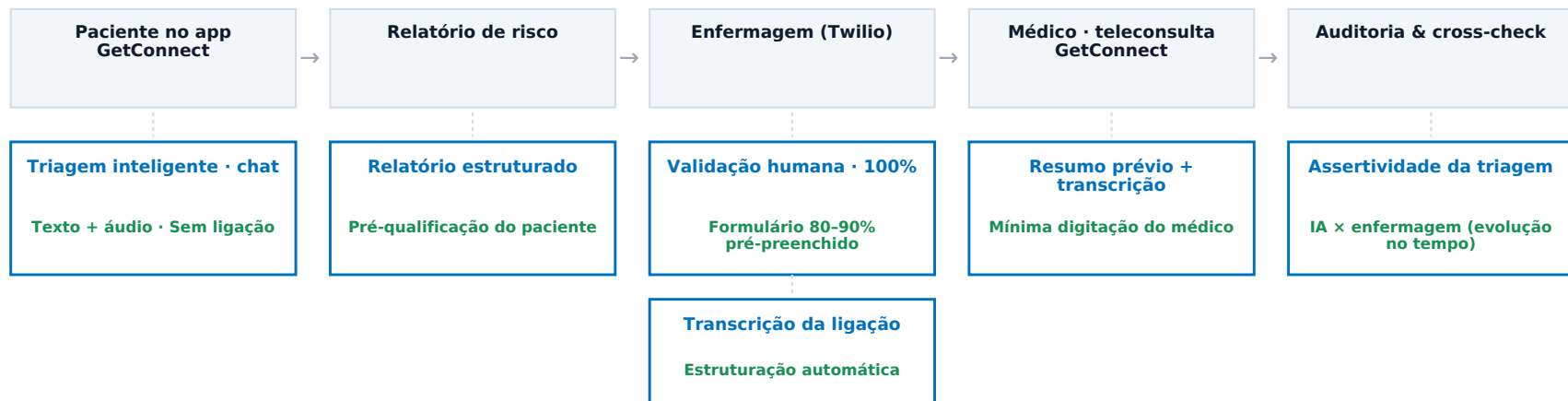
SEÇÃO 06 · JORNADA DO ATENDIMENTO

A jornada do atendimento

Paciente → Triagem IA (app GetConnect) → Enfermagem (Twilio) → Auditoria → Médico (teleconsulta) → Prontuário estruturado.

Camada de IA clínica embarcada na jornada GetConnect · validação humana obrigatória.

Gestão & Auditoria (Dashboards) · Visão da jornada PS Digital



IA como apoio à decisão · enfermagem valida 100% dos casos

Governança preservada para o setor público

□ Produto Doutor-AI

□ Etapa da jornada GetConnect

▸ SEÇÃO 07 · INTEGRAÇÕES, DADOS & LGPD

O que precisa *conversar*

Integração via API/SSO ao ecossistema existente — sem troca de sistema. Custos de terceiros (Twilio, WhatsApp, SMS, telefonia) cobrados à parte.

Ponto de integração / dependência	Descrição	Status
App GetConnect	Paciente inicia o atendimento; triagem por IA embarcada (texto + áudio), no app e no totem.	EXISTENTE
Plataforma web GetConnect	Telemedicina/teleconsulta; transcrição e prontuário estruturado.	EXISTENTE
Twilio	Captura do áudio das ligações da enfermagem (~90% dos atendimentos) para transcrição.	PENDENTE ALINHAMENTO
Prontuário GetConnect	Templates de anamnese, evolução e conduta adaptados aos campos atuais.	PENDENTE FORMULÁRIOS
Protocolo clínico (Medkitor)	Substituição do protocolo internacional usado hoje (Medkitor) pela triagem Doutor-AI.	DEPENDÊNCIA

▸ DADOS & LGPD

- **Papéis:** GetConnect = Controladora · Doutor-AI = Operadora.
- Incidentes de segurança: notificação em até 48h.
- Supervisão humana obrigatória em decisão clínica.
- Dados anonimizados/agregados p/ treino; reversibilidade CSV/JSON em 30d.

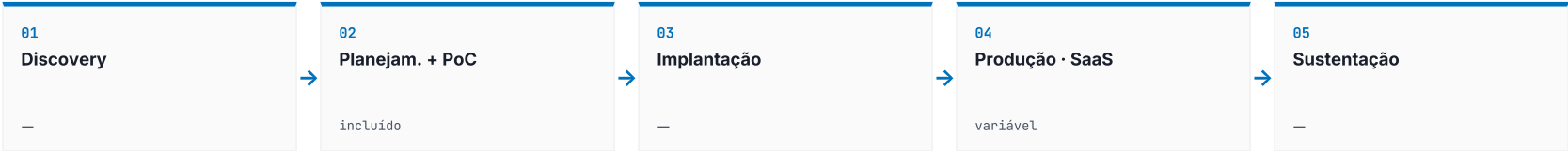
▸ SLA & SUPORTE

- Disponibilidade-meta 99,5%/mês (obrigação de meio).
- Suporte seg-sex, 9h-18h; plantão p/ indisponibilidade total.
- 1º retorno: Altíssimo 2h · Alto 4h úteis.
- Médio 1 dia útil · Baixo 2 dias úteis.

SEÇÃO 08 · CONTRATO & PRECIFICAÇÃO

Etapas e custos

A sequência de custos do projeto e o que incide em cada etapa. A recorrência usa a janela de volume real do GetConnect (a tabela completa está na próxima seção).



CUSTO POR ETAPA & COMPOSIÇÃO

Etapa	Custo	Composição
Discovery	—	80h · one-off na assinatura
Planejamento + PoC	incluído	protótipo do fluxo rodando p/ validação
Implantação	—	cronograma definido no Discovery
Produção (SaaS)	variável	Σ por etapa × volume (tabela completa →)
Sustentação	—	sob demanda (evoluções / suporte)

⚠ Resolver internamente a divergência de descontos de prazo: 5/10/15% (cláusula 1.2) vs 2,5/5/10% (tabela). Valores indicativos até visibilidade real de consumo.

JANELA ATUAL DO GETCONNECT (TIER ENTERPRISE ≤100K)

Produto	Unitário	Faixa
Triagem		—
Teleconsulta		—
Auditoria		—

Volume 60K→100K · apurado mensalmente pelo volume efetivo. Faixa = preço inicial → mínimo.

SEÇÃO 10 • TAMANHO DO PS DIGITAL & MRR

Tamanho e *receita* por fase

Quebrando o tombamento em fases e estimando o MRR potencial do cliente em cada momento — visibilidade de receita do PS Digital.

Momento	Horizonte	Volume / mês	MRR estimado	ARR estimado
M1 • Tombamento	Curto prazo	60.000		
M2 • Pós-consórcio	Médio prazo	90.000		
M3 • PS Digital maduro	Longo prazo	100.000		
M4 • Consórcio total	Expansão (futuro)	~250.000		

Premissas (indicativo, ajustável): tier Enterprise (faixa atual); cobertura assumida: triagem 100% • enfermagem 100% • teleconsulta médica 35% • auditoria 100%. M4 (consórcio: crônicos + atenção especializada) tem mix e tiers distintos; upside fora do MVP. Estimativa indicativa, não é compromisso de receita.

FRENTE 1 • MAIS URGENTE

Triagem no totem

Triagem inteligente no totem físico do PS Digital.

NOVO • não constava na proposta

FRENTE 2 • CONFORME PROPOSTA

Triagem no app + copiloto

Triagem no app e-Saúde com o fluxo completo de copiloto da enfermagem e do médico.

PROPOSTA ORIGINAL

▸ SEÇÃO 11 · RISCOS, EXCLUSÕES & LIMITAÇÕES

O que *vigiar*

▸ RISCOS

- Integração Twilio pendente de alinhamento (pré-requisito do go-live)
- Formulários/prontuário da enfermagem ainda não recebidos
- Substituição do protocolo Medkitor a validar com o cliente
- Adesão e conservadorismo do setor público
- Divergência de descontos no anexo de preços (resolver)

▸ EXCLUSÕES

- Domínios não contratados (PS Físico, Internação, etc.)
- Faturamento e Gestão de Contratos
- Crônicos e Atenção Especializada (consórcio)
- Substituição da plataforma assistencial GetConnect

▸ LIMITAÇÕES

- Implantação por horas — , definidas no Discovery
- Suporte em horário comercial
- IA é obrigação de meio, não de resultado
- Responsabilidade clínica integral do cliente

▸ SEÇÃO 12 • CRONOGRAMA

As etapas *macro*

Da contratação ao go-live. Os prazos são estimativas iniciais, a detalhar e confirmar no Discovery.



▸ AÇÕES IMEDIATAS

- Enviar o e-mail de ativação dos domínios (Triagem, Teleconsulta, Auditoria).
- Confirmar o e-mail oficial de notificações da GetConnect.
- Confirmar o pagamento do Discovery —
- Agendar o Discovery e o kick-off técnico.
- Obter formulários da enfermagem e campos do prontuário.
- Alinhar Twilio, totem e a substituição do Medkitor.